

一、疾病理解與病理機轉

憂鬱症不是單純的心情不好,而是大腦功能失調導致情緒持續低落、失去快樂感的一種疾病。患者會感到持續的悲傷、對事物失去興趣、自信心下降,同時伴隨身體上的變化如食慾不振、體力變差、睡眠障礙等。這就像大腦的『情緒調節器』故障了,需要透過藥物和心理治療來幫助修復。焦慮症則是過度的擔心和緊張感,身體會出現心跳加速、呼吸困難等自律神經失調症狀,嚴重影響日常生活功能。

二、藥物知識與服藥遵從

1. 抗憂鬱藥物需要持續服用2~4週才會逐漸見效,不可自行停藥或調整劑量。
2. 鎮定劑用於緩解急性焦慮症狀,需按醫師指示使用避免依賴。
3. 情緒穩定劑用於雙極症治療,需定期監測血中濃度。
4. 所有精神科藥物都可能產生副作用,如頭暈、嗜睡等,服藥後不適應立即告知醫護人員。
5. 服藥期間需配合心理治療,學習情緒調適技巧。

三、警訊辨識與處置行為

1. 出現自殺念頭或傷害自己/他人的行為時,立即就醫或撥打緊急電話。
2. 情緒極度低落、無法執行日常活動超過兩週,需盡快回診。
3. 出現躁症症狀如過度興奮、亂花錢、睡眠需求減少持續4~7天,應尋求醫療協助。
4. 焦慮症狀嚴重到無法呼吸、心跳過快時,需立即就醫。
5. 藥物副作用嚴重影響生活時,應聯繫醫師調整用藥。

四、飲食與活動建議

1. 保持規律三餐飲食,避免暴飲暴食或完全不吃。
2. 適度曬太陽每天15~30分鐘,有助調節情緒改善憂鬱。
3. 每週進行3~5次中等強度運動,如散步、游泳每次30分鐘。
4. 避免飲用過多咖啡、茶等刺激性飲料。
5. 維持規律作息,每天睡眠7~8小時,避免熬夜。
6. 參與休閒活動如園藝、閱讀,增加生活樂趣。

五、出院追蹤與門診照護導引

1. 定期每1~2週回精神科門診追蹤,醫師會評估病情調整藥物。
2. 配合心理治療師安排會談,學習情緒管理技巧。
3. 參加醫院舉辦的支持團體或衛教課程。
4. 建立緊急聯絡網絡,包括家人、醫師電話。
5. 記錄情緒日記,回診時提供醫師參考。
6. 若需轉介其他專科(如內科、神經科),由主治醫師協助安排。

六、慢性疾病追蹤與照護提醒

【個人化慢性疾病追蹤與照護提醒】

以下慢性病是依診斷 ICD-10 自動辨識,請配合醫師門診追蹤與用藥調整。

■ 第二型糖尿病(ICD-10: E1142)

- 目前用藥中可能包含降血糖藥或胰島素,請規律監測血糖,並留意冒冷汗、手抖、心悸等低血糖症狀。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 依醫師指示定時測量血糖,餐前目標 80~130 mg/dL,餐後2小時目標 < 160 mg/dL。
- 詳細記錄每次血糖值(日期、時間、餐前/後、藥物劑量),回診時提供醫師調整劑量。
- 每日檢查雙腳皮膚,選擇棉質吸汗襪與寬頭透氣鞋,避免赤腳或穿夾腳拖。

■ 逆流性食道炎(ICD-10: K219)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 飯後不立即平躺,睡前2小時避免進食;抬高床頭約15公分可減少夜間逆流。
- 避免油膩、辛辣、巧克力、咖啡、酒精等刺激性食物。
- 按醫師指示服用制酸劑或質子幫浦抑制劑,即使症狀消失也需依醫囑完成療程。

■ 慢性阻塞性肺疾病(ICD-10: J449)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日進行腹式呼吸與噁嘴呼吸訓練,每次10分鐘,每天3次,可增加活動耐力。
- 依醫師指示使用吸入型支氣管擴張劑,正確使用吸藥器是治療關鍵。
- 出現呼吸急促明顯惡化、痰量或痰色改變、發燒時,需立即就醫。

■ 高血脂症(ICD-10: E785)

- 目前用藥中可能包含降血脂藥物,請按時服用;若有明顯肌肉痠痛或茶色尿,請告知醫療人員。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 減少高膽固醇及飽和脂肪攝取,選擇清蒸、水煮等低油烹調方式,增加膳食纖維。
- 規律運動(每週至少3次,每次30分鐘以上),維持理想體重。
- 按時服用降血脂藥物,不可自行增減劑量或停藥;定期抽血追蹤膽固醇數值。

■ 甲狀腺功能低下(ICD-10: E038)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日固定時間空腹服用甲狀腺素(Levothyroxine),服藥前後1小時避免喝牛奶或服用鈣片。
- 不可自行調整劑量;定期抽血監測 TSH,通常每6個月追蹤一次。

■ 高血壓(ICD-10: I129)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日早晚各量一次血壓,遵循 722 原則(7天、每日早晚各1次、每次量2遍),記錄後回診時提供醫師參考。
- 每日鹽分攝取限制在 2~4 公克,採用 DASH 飲食(多蔬果、全穀、低脂)。
- 規律服用降壓藥,不可自行停藥或減量;戒菸、限酒、維持 BMI 20~25。

■ 慢性腎臟病(ICD-10: N189)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 採低磷、低鉀飲食(視腎功能分期調整),蔬菜煮熟後倒掉湯汁可降低鉀含量。
- 嚴格限制液體及鹽分攝取,避免使用止痛藥(NSAIDs)或來路不明的中草藥。
- 定期回診追蹤腎功能(尿素氮、肌酸酐、電解質),準時接受透析治療(若需要)。

■ 雙極症(ICD-10: F319)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 規律服用情緒穩定劑(如鋰鹽、Valproate),不可自行停藥;定期抽血監測藥物濃度。
- 維持規律作息與充足睡眠,避免過度刺激或壓力;記錄情緒日記有助於病情追蹤。

七、參考衛教手冊

1. 憂鬱症
2. 糖尿病足部病變護理指導
3. 焦慮症
4. 急性呼吸衰竭
5. 慢性阻塞性肺疾病
6. 住院病人就醫安全守則
7. 血糖自我監測衛教指導
8. 逆流性食道炎護理指導
9. 高血脂症護理指導
10. 高血壓
11. 末期腎臟疾病
12. 雙極症

※ 此衛教手冊由人工智慧輔助生成，僅供參考，不代替醫師專業建議。

生成日期：2026-05-31